CROIX-ROUGE FRANÇAISE

NOM DE L'ENTITÉ : C2 INTERNE

ÉMETTEUR : National

DESTINATAIRES : *DUO, DTUS IDF*

VERSION : 01 | **DATE D'APPLICATION :** 14/10/2024

DATE DE RÉVISION : 14/11/2024

Mise à jour règlementaire et procédurière concernant le SSUAP à la BSPP

Pour rappel, les intervenants de la Croix-Rouge française en centre de secours de la BSPP sont tenus de respecter la réglementation interne en vigueur au sein de la BSPP, dans le cadre strict de leur formation et de leur dotation en matériel.

Les éléments présentés ici doivent être diffusés uniquement en interne.

Réglementation BSPP

BSP 115.1

Mise à jour demande d'escorte motorisée

Note de référence : *A venir*

Emplacement : Partie 1, titre 4, paragraphe 6 - Escorte motorisée (page 27)

Synthèse de la mise à jour : désormais, en cas de besoin d'une escorte motorisée sur intervention, en présence ou non des forces de l'ordre et que ce soit au profit d'une équipe médicale BSPP ou SAMU, la demande sera effectuée par le COS auprès du CSO TC, sous la forme : "je demande une escorte motorisée …"

BSP 118

Mise à jour demande d'un véhicule de transport bariatrique (VTBA)

Note de référence : NE 511554

Emplacement : Partie 7, titre 8, paragraphe 3 et 4 - Emploi du véhicule de transport bariatrique (VTBA) (page 153 et 154)

Synthèse de la mise à jour : disparition de la notion "après validation de la CM" et disparition du bon à savoir : "le vecteur est engagé sur demande du chef d'agrès et sous réserve de sa disponibilité"

BSP 200.2

Mise à jour sur les cas de demande de police

Emplacement : Chapitre 1, titre 1.4, paragraphe D - Sur les lieux de l'intervention (page 47)

Synthèse de la mise à jour : ajout des cas de demande de police pour la victime mineure ayant échappé à la surveillance des secours avant la transmission de responsabilité au personnel hospitalier

Mise à jour sur les cas de décès certains

Emplacement : Chapitre 1, titre 1.5, paragraphe B - Les personnes décédées (page 59)

Synthèse de la mise à jour : ajout d'un paragraphe précisant la conduite à tenir sur les morts suspectes

Mise à jour sur la mise en évidence de l'arrêt respiratoire

Emplacement : Chapitre 4, titre 4.3, paragraphe B4 - Le bilan primaire de la victime en arrêt respiratoire (page 147 à 151)

Synthèse de la mise à jour : ajout de deux algorithmes précisant les différentes conduites à tenir selon le nombre de mouvements respiratoires identifiés dans le bilan

Création prise en charge et contact pour une intervention avec quelques victimes

Emplacement : Chapitre 4, titre 4.6, paragraphe F - Cas particulier : la prise en charge et le contact pour une intervention avec quelques victimes (page 161 à 162)

Synthèse de la mise à jour : description d'une conduite à tenir type, abordant notamment la demande de renfort (1 équipe médicale par UA, 1 équipe médicale au besoin pour le triage, 1 VSAV par victime, les moyens complémentaires, etc), le contact à la coordination médicale de manière groupée si possible avec les CA des VSAV, etc. Le déclenchement et la mise en œuvre de SINUS à partir de 5 victimes sont facilités par la demande d'un groupe SSUAP.

Création rôle du VSAV sur feu

Emplacement : Chapitre 4, titre 4.6, paragraphe F - Le VSAV sur feu (page 162)

Ne concerne pas en première intention les AASC engagées en CS, mais la conduite à tenir reste intéressante et pertinente, évoquant à la fois la prise en charge des victimes sur feu, mais aussi la notion de remise en condition du personnel.

Création gestion du dispositif "life vest"

Emplacement : Chapitre 7, titre 7.2, paragraphe C1 - La réanimation cardio-pulmonaire en équipe avec matériel (page 211)

Synthèse de la mise à jour : ajout d'un algorithme sur la gestion des life vest sur intervention et précision sur la conduite à tenir selon l'état de conscience de la victime, les différentes alarmes, la gestion du gilet et du chargeur en cas de transport, etc.

Mise à jour glucagon intranasal

Emplacement : Chapitre 9, titre 9.3, paragraphe C - Conduite à tenir spécifique (page 251)

Synthèse de la mise à jour : Ce dispositif peut être utilisé par les secouristes lorsque l'administration de sucre est impossible, voire dangereuse, et ne peut se faire que sur ordre de la coordination médicale chez une personne traitée par insuline et présentant une hypoglycémie avec troubles de la conscience.

Création premiers secours psychologique en opération

Emplacement : Chapitre 10 - Prise en compte de la dimension psychologique en intervention et sensibilisation aux risques psychologiques professionnels (page 263 à 287)

Synthèse de la mise à jour : refonte du chapitre, initialement sur les comportements inhabituels et la souffrance psychique, désormais sur la prise en compte de la dimension psychologique en intervention. Aborde les différents stress et événements traumatisants, la notion de souffrance psychique, les différentes manifestations de la détresse psychologique et de l'état de crise, etc. Développe les conduites à tenir associées.

Création personne menaçant de se jeter dans le vide

Emplacement : Chapitre 10, titre 10.1, paragraphe D3 - La personne menaçant de se jeter dans le vide (page 276)

Synthèse de la mise à jour : ajout d'un paragraphe sur la thématique, donnant la conduite à tenir et abordant notamment les pratiques avant et pendant l'intervention (gestion des avertisseurs sonores et lumineux, distance avec la victime, gestion de l'entourage, etc).

Création d'un dépliant CUMP (BOPE 35)

Emplacement : Chapitre 10, titre 10.1, paragraphe A2 - L'événement potentiellement traumatisant (page 265)

Synthèse de la mise à jour : dépliant disponible dans les véhicules de la BSPP (à l'image des autres documents administratifs opérationnels), il doit être remis aux victimes et impliqués à la suite d'un événement potentiellement traumatisant, notamment :

- les victimes ou témoins directs d'une agression extrêmement violente ou d'un crime
- les témoins direct d'une victime gravement blessée ou décédée (en cas d'exposition à un corps particulièrement abimé)
- les personnes découvrant une victime gravement blessée ou décédée (pendaison, corps en décomposition, etc)

Mise à jour intoxication par produits stupéfiants

Emplacement : Chapitre 11, titre 11.4, paragraphe C - Conduite à tenir spécifique (page 300)

Synthèse de la mise à jour : précision sur les victimes inconscientes en contexte d'intoxication aux opiacés, avec une différence dans la conduite à tenir en fonction de la fréquence respiratoire

Création de fiches de conseil pour les traumatisés crâniens légers (BOPE 34 et 34 bis)

Emplacement : Chapitre 15, titre 15.9, paragraphe D - Conduite à tenir spécifique (page 404)

Synthèse de la mise à jour : Précision dans le tableau des conduites à tenir sur ces deux nouvelles fiches (BOPE 34 pour les adultes, BOPE 34 bis pour les mineurs), à avoir dans les véhicules de secours. Elles seront laissées à la victime (BOPE 34) ou au représentant légal (BOPE 34 bis) après décision de la coordination médicale de laisser la victime sur les lieux.

Mise à jour sur les réductions de luxation de rotule

Emplacement : Chapitre 15, titre 15.9, paragraphe D - Conduite à tenir spécifique (page 403)

Synthèse de la mise à jour : ajout d'un lien vers une vidéo pédagogique sur la réduction de rotule. Ne peut être visionnée que sur un ordinateur BSPP.

Mise à jour sur le matériel à emporter en cas de situations à nombreuses victimes

Emplacement : Chapitre 19, titre 19.1, paragraphe C - Les principes d'organisation (page 444)

Synthèse de la mise à jour : ajout d'un paragraphe dans les principes d'organisation sur le matériel à prendre en cas de nécessité d'extraction des victimes vers un PRV ou un PMA. Seuls les kits hémorragies, les brancards et civières sont utiles immédiatement, le reste du matériel étant avancé et laissé au PRV/PMA ou récupéré secondairement en fonction des situations.

Mise à jour sur la mort inattendue du nourrisson avec les indications de la RCP et la demande de police associée

Emplacement : Chapitre 20, titre 20.4, paragraphe E - La mort inattendue du nourrisson (page 468 à 469)

Synthèse de la mise à jour : séparation du paragraphe "prise en compte de la mort inattendue du nourrisson" en deux paragraphes distincts : "faut-il entreprendre une réanimation lorsqu'un nourrisson présente une raideur cadavérique ?" et "faut-il demander la police en présence d'une mort inattendue du nourrisson ?".

Concernant la RCP en cas de raideur cadavérique, celle-ci peut être réalisée à titre symbolique en l'attente de l'équipe médicale notamment en présence de signes évocateurs d'un décès certain non-susceptibles d'être perçu par les parents.

Concernant la demande de police, il est rappelé que celle-ci n'est pas systématique, sauf en cas de signes évocateurs de maltraitance et que la situation doit être évaluée au cas par cas en fonction des éléments

recueillis ou d'accord interservices départementaux dont le médecin a connaissance. Dans tous les cas, il faudra attendre le médecin pour effectuer la demande.

Mise à jour fiche technique FT 7.1 : Bionettoyage du matériel de secours

Emplacement : FT 7.1 (page 511 à 513)

Synthèse de la mise à jour : Réécriture du paragraphe d'introduction, et mise à jour du nombre de SP nécessaire, des risques et contraintes, de la pré-désinfection du matériel (15 minutes de trempage), différenciation sur les seaux utilisés pour le matériel non immergeable et pour le sol du véhicule et ajout d'un cas particulier avec la gestion des dispositifs médicaux électroniques.

Mise à jour fiche technique FT 14.1 : Apprécier ou évaluer la respiration par la recherche des mouvements respiratoires

Emplacement : FT 14.1 (page 574)

Synthèse de la mise à jour : précisions sur la mise en évidence de l'arrêt respiratoire en cas de doute, en différenciant la conduite à tenir en fonction du nombre de mouvements respiratoires présents sur 10 secondes. En l'absence de mouvement, il s'agit d'un arrêt respiratoire; en présence d'un seul mouvement sur 10 seconde, il faut refaire une évaluation sur 10 secondes maximum et adapter la conduite à tenir en fonction; en présence de deux mouvements ou plus, il ne s'agit pas d'un arrêt respiratoire.

Mise à jour fiche technique FT 21.4 : Naloxone intranasale

Emplacement : FT 21.4 (page 625 à 626)

Synthèse de la mise à jour : simplification de la fiche technique évitant la répétition avec le chapitre sur les intoxications. Paragraphe sur la conduite à tenir en cas de victime inconsciente sur un contexte d'intoxication aux opioïdes enlevé.

Création fiche technique FT 21.5 : Administration de glucagon par voie intranasale pour le resucrage d'une hypoglycémie

Emplacement : FT 21.5 (page 627 à 628)

Synthèse de la mise à jour : Création de la fiche.

Mise à jour fiche technique FT 23.1 : Mise en oeuvre d'un DAE

Emplacement : FT 23.1 (page 642)

Synthèse de la mise à jour : Ajout d'un tableau récapitulant les différents DSA/DAE rencontrés sur intervention et leur utilisation en mode "normal" comme en mode "dégradé".

Création fiche technique FT 42.1 : Mener un defusing à l'issue d'une intervention sensible

Emplacement : FT 42.1 (page 809 à 810)

Synthèse de la mise à jour : Création de la fiche.

Création fiche technique FT 42.2 : Pratiquer la respiration contrôlée à des fins de relaxation

Emplacement : FT 42.2 (page 811 à 812)

Synthèse de la mise à jour : Création de la fiche.

Notes techniques

Couverture opérationnelle - rédaction en cours

A compter du 1er janvier 2025, les modifications suivantes devraient prendre effet :

- suppression du CD LAND, pour ne conserver que 3 CD (1 par GIS) qui se répartissent la charge de l'intra-muros

Lexique des termes employés

Acronyme	Signification
AASC	Association Agréée de Sécurité Civile
BSPP	Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
CA	Chef d'Agrès
CD	Camion de Désincarcération
CM	Coordination Médicale
COS	Commandant des Opérations de Secours
CS	Centre de Secours
CSO TC	Centre de Suivi Opérationnel Territorialement Compétent
FT	Fiche Technique
GIS	Groupement d'Incendie et de Secours
PMA	Poste Médical Avancé
PRV	Point de Regroupement des Victimes
RCP	Réanimation Cardio-Pulmonaire
SAMU	Structure d'Aide Médicale Urgente
SINUS	Système d'Information NUmérique Standardisé
SSUAP	Secours et Soins d'Urgence Aux Personnes

UA	Urgence Absolue
VSAV	véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes
VTBA	Véhicule de Transport BAriatrique